폐경 진단과 호르몬치료 지속 판단

검사 · 출혈 평가 · 혈전 위험 · 연자 Q&A의 지속 판단

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

연령과 무월경 기간으로 진단 경로를 나눈다

강의·교재의 NICE NG23 임상 진단 경로와 연령별 검사 선택

45세 이상	다른 뚜렷한 원인 없이 **12개월 연속 무월경**이면 호르몬검사 없이 임상적으로 자연폐경을 진단한다.
40–45세	폐경 증상과 **12개월 무월경**을 확인한다. 강의는 진단을 위해 **FSH·E2 검사**를 시행할 수 있다고 설명했다.
40세 미만	폐경 유사 증상과 월경 이상이 있으면 **POI 평가**로 전환한다. 일반적인 자연폐경과 구분한다.

이른폐경(early menopause): **45세 미만** · 조기난소부전(POI): **40세 미만** — 용어를 혼용하지 않는다.

전형적인 자연폐경의 임상 진단과 젊은 연령에서의 난소기능 평가를 구분한다.

주기 변동에서 무월경으로 이행한다

교재 STRAW+10 도식의 병기와 진단 시점

Reproductive

생식기

규칙적인 월경주기

Early MT · −2

이행기 초기

주기 변이 **≥7일**

Late MT · −1

이행기 후기

무월경 **≥60일**

FMP · 0

마지막 월경

폐경 진단의 기준점

Postmenopause · +1a

폐경 후

무월경 **12개월 경과** 시점

시점과 증상을 함께 해석

폐경은 마지막 월경 이후 12개월 연속 무월경을 확인해 진단한다. 폐경 후에는 혈관운동증상과 비뇨생식기 위축이 동반될 수 있다.

폐경이행기에는 주기 변동이 크며, 연령과 증상을 함께 해석한다.

FSH 단회 측정으로 폐경을 확정하지 않는다

이행기의 호르몬 변동과 피임제 사용이 해석에 영향을 준다

이행기의 FSH 변동

이행기에는 FSH 변동이 커 한 번 측정한 수치만으로 폐경 여부를 확정하지 않는다.

선택적인 검사

연령과 폐경 증상, 월경 양상을 함께 보고 FSH·E2 검사가 필요한 상황을 선택한다.

호르몬 피임제·IUD

호르몬 피임제 또는 호르몬 함유 자궁내장치(IUD)를 사용하면 출혈 양상만으로 폐경을 판단할 수 없다.

병력 우선

현재 피임법과 호르몬 사용 여부를 확인한 뒤 월경 변화의 의미를 해석한다.

검사 수치나 출혈 패턴 하나만으로 결론을 내리지 않고 사용 약제와 임상 경과를 함께 본다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

생리를 하지 않아도 임신 가능성을 확인한다

이행기에도 간헐적으로 배란이 발생할 수 있다

간헐적 배란	폐경이행기 중에도 배란이 발생할 수 있어 임신 가능성이 남아 있다. 무월경만으로 임신을 제외하지 않는다.
무월경의 첫 평가	가임 가능성이 있는 여성에서는 임신인지 먼저 확인한다. 이행기라는 이유만으로 무월경을 설명하지 않는다.
피임 상담	현재 피임 방법과 정확한 사용 여부를 확인하고, 이행기에도 피임 상담을 함께 시행한다.

폐경 진단의 문진에는 월경력뿐 아니라 임신 가능성과 호르몬 피임제 사용력이 포함된다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

폐경 후 출혈은 양이 적어도 원인을 평가한다

소량·일시적 출혈도 자궁내막암 감별의 대상이다

약 10%

폐경 후 출혈 → 자궁내막암

교재는 폐경 후 출혈에서 약 10%가 자궁내막암으로 진단된다고 설명한다.

90%

자궁내막암의 50세 이후 발생

교재의 연령 분포 수치다. 자궁내막암의 가장 흔한 증상은 비정상 자궁출혈이다.

소량·일시적 출혈도 평가

비만·당뇨·타목시펜·가족력, 호르몬 사용력을 확인한다. 출혈량이 적어도 자궁내막암을 배제한다.

자궁경부와 구조적 원인

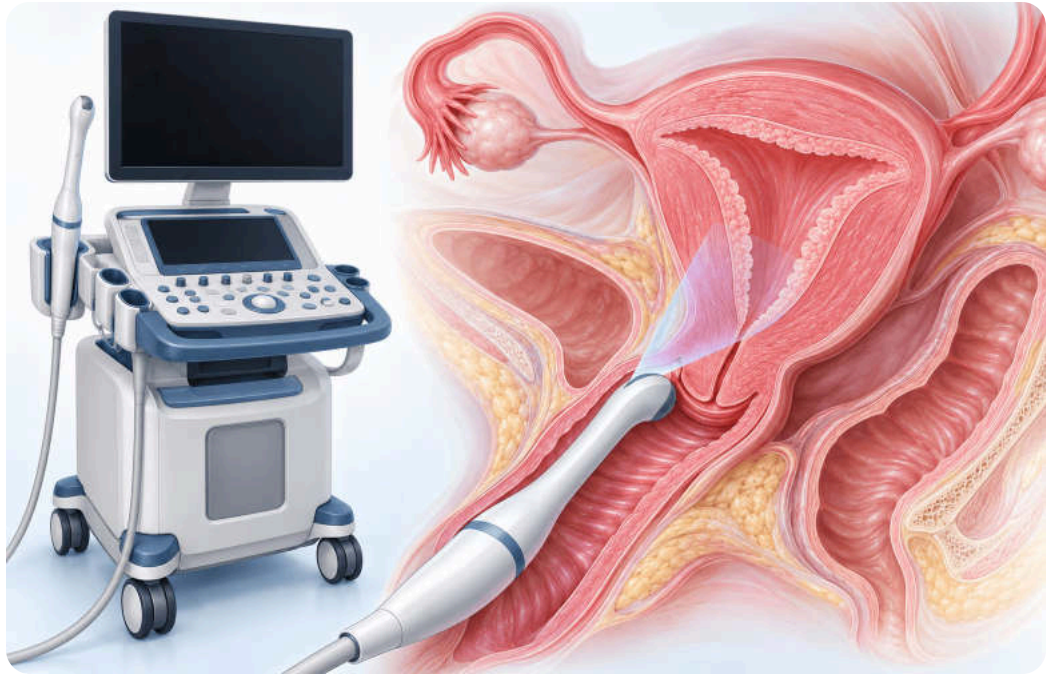
성교 후 출혈과 경부 병변도 평가한다. Pap·HPV 검사력을 확인하고, 영상·조직검사로 구조적 원인을 먼저 살핀다.

폐경 후 출혈을 단순한 주기 변화로 해석하지 않고 구조적 원인과 악성질환을 먼저 평가한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

경질초음파와 조직 평가를 연결한다

폐경 후 출혈에서 자궁내막 두께와 병변을 함께 본다



초음파상 자궁내막 두께·병변과 출혈의 임상 맥락을 함께 평가한다.

경질초음파(TVUS)

불규칙 출혈의 일차 영상검사로 자궁내막 두께와 용종·근종·선근증 등 병변을 평가한다.

내막 두께와 생검

폐경 후 출혈에서 강의는 **4–5 mm**를 내막 두께의 기준으로 설명하고, 이를 초과하면 자궁내막 생검을 고려하도록 강조했다.

질경검사

자궁경부의 국소 병변과 출혈 부위를 직접 확인한다. 육안 병변이 있으면 조직 평가를 연결한다.

초음파는 내막 두께뿐 아니라 구조적 병변을 확인하는 검사다.

용종과 자궁내막 병변은 조직 평가로 연결한다

초음파·질경검사에서 발견한 병변과 생검 결과에 따른 다음 단계

용종의 조직학적 확인

폐경 후 용종이나 비정상 출혈을 동반하면 조직학적으로 확인한다.
강의 슬라이드: 악성률 1–3%.

자궁강·자궁경부 병변

자궁내막 용종은 TVUS·식염수 주입 초음파(SIS)·자궁경검사로 평가한다. 경관 용종은 질경검사로 확인하고 제거 후 조직검사를 시행한다.

외래 자궁내막 생검

폐경 후 출혈에서 내막 두께가 기준을 초과하면
Pipelle 생검을 연결한다.

↓

검체 불충분·비진단적 결과

자궁경검사 + 조직생검·소파술(D&C)로 이어 자궁내막 병변을 확인한다.

PALM: 용종(P)·선근증(A)·근종(L)·악성/증식증(M)을 먼저 평가한다. 여러 원인이 공존할 수 있다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

증상·골·심혈관 위험과 금기를 함께 평가한다

폐경호르몬요법(menopausal hormone therapy, MHT)의 개별화

치료할 증상

안면홍조·야간발한 등 혈관운동증상(vasomotor symptoms), 수면장애와 비뇨생식기 증상을 확인한다.

기저 위험

골다공증과 심혈관 위험요인, 기저 병력을 평가한 뒤 치료 여부를 결정한다.

금기·과거력

유방암·혈전증 병력 등 적응증과 금기사항을 확인한다. 증상의 정도와 함께 치료 방향을 논의한다.

동반 건강 관리

골밀도·지질·혈압 등 전신 건강을 평가하고 정기 모니터링을 치료 계획에 연결한다.

호르몬치료의 시작과 지속은 증상만이 아니라 기저 병력과 전신 위험을 함께 보고 결정한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강의는 저용량부터 개별화한 치료를 설명했다

호르몬요법 선택지와 비호르몬 선택지를 구분한다

EPT

에스트로겐–프로게스토겐 병합요법 (estrogen–progestogen therapy). **자궁 보유 여부**를 포함해 선택한다.

STEAR·TSEC

강의가 설명한 호르몬요법 선택지. 적응증과 금기를 평가한 뒤 **저용량부터 개별화**한다.

비호르몬 선택지

교재의 비호르몬 옵션: **SSRI/SNRI**. 증상과 기저 병력에 따른 치료 논의에 포함한다.

생활습관 교정

수면위생 · 카페인 제한을 안내한다. 강의 슬라이드에서는 **규칙적 운동 · 적정 체중 · 금연·절주**를 함께 제시했다.

약제 선택은 적응증과 금기 평가를 거친 개별화 계획에 연결한다.

비뇨생식기 증상과 골·대사 건강을 함께 다룬다

심한 질건조감에는 국소 에스트로겐 병용을 설명했다

질건조감·성교통

비뇨생식기 증상(genitourinary syndrome of menopause, GSM)이 있는지 평가한다.

국소 에스트로겐

특히 질건조감이 심하면 국소 에스트로겐 병용이 치료 선택이라고 설명했다.

골 건강

골밀도 검사(DXA)와 골다공증 위험 평가를 치료 계획에 연결한다.

심혈관·대사

지질·혈압 등 심혈관 위험을 정기 모니터링한다. **강의 슬라이드: 연 1회 유방검진 및 치료 지속 여부 재평가**를 함께 제시했다.

전신 증상 치료와 국소 증상 치료, 골·대사 건강 평가를 함께 연결한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

D-dimer 결과만으로 중단하는가?

고령 여성의 호르몬치료 지속에 대한 연수강좌 질의응답

질문 · 중단 권고와 SERM 전환

연자 Q&A · 질문

60세 이후에도 심한 혈관운동증상으로 호르몬제를 중단하기 어려운 상황이었다. D-dimer 상승으로 중단을 권고받아 **SERM 제제로 변경**한 경위와 지속 기준을 질문했다.

답변 · D-dimer 단독 중단 기준

연자 Q&A · 답변

연자는 **D-dimer 결과만으로 호르몬요법을 중지하라는 가이드라인은 없다고 답했다.**

답변 · 검사를 반복

연자는 먼저 **검사를 반복**해 보도록 설명했다. 경피 제제 전환에 대한 답변은 다음 슬라이드에 정리했다.

연자 Q&A · 질문자의 SERM 전환 경위와 연자의 D-dimer 재검 답변을 구분한다.

고령 여성에서 경피 제제 전환을 답변했다

다음 내용은 해당 질문에 대한 연자의 답변이다



연자 Q&A에서 경피 제제 전환을 언급한 투여 경로를 시각화했다.

경피 에스트로겐

연자 Q&A

연자는 **65세 이상**에서 transdermal 제제로 변환하면 더 안전하게 사용할 수 있다고 답했다.

답변에서 언급한 제제

에스트레바겔 2–3 pump/d로 전환하는 방안을 설명했다.

답변의 적용 맥락

D-dimer 상승으로 중단을 권고받은 고령 여성의 질문에 대한 **연자 Q&A 답변**이다. 경피 제제로의 전환 방안을 제시했다.

연자 Q&A · 제제와 용량은 이 질문에 대한 답변으로 귀속한다.

매년 이익과 위험을 다시 평가한다

연수강좌 질의응답에서 설명한 지속 판단의 기준

질문자의 관리 맥락

연자 Q&A · 질문 심혈관 위험도가 낮고, 혈관운동증상이 심해 중단하기 어려운 경우의 지속 판단을 물었다.

질문에서 병행한 연간 평가

- 유방암 검진 · 부인과검진
- 당뇨 스크리닝
- 고지혈증 스크리닝

연자의 지속 기준

연자 Q&A · 답변 **매년 평가에서 호르몬치료의 이익이 위험을 상회하면 계속 치료할 수 있다**고 답했다.

치료 지속과 다음 평가

연자의 답변은 **매년의 이익·위험 재평가**를 전제로 한다. 질문자가 병행한 검진·스크리닝과 답변의 판단 기준을 구분해 읽는다.

연자 Q&A · 검진·스크리닝 목록은 질문자의 관리 내용이며, 지속 기준은 연자의 답변이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

진단에서 출혈 평가와 지속 판단까지 연결한다

강의 본문과 Q&A의 맥락을 구분해 정리한다

1

진단

연령·월경력·호르몬 사용력과 증상을 확인하고 검사 필요성을 정한다.

2

출혈 평가

폐경 후 출혈에서는 초음파와 조직 평가로 구조적 원인을 확인한다.

3

치료 선택

적응증·금기·기저 위험을 평가하고 증상에 맞게 치료를 개별화한다.

4

지속 재평가

연자 Q&A

매년 이익과 위험을 비교해 지속 여부를 판단한다.

임상 진단·출혈 평가·치료 선택·연간 재평가를 서로 다른 판단 단계로 구분한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

의료진 강의 학습 자료 · QR로 다시 보기

광교바른내과 · 031-893-4560

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

의료진 학습용으로 이사라 연자의 월경 불규칙 강의 내용을 정리했다. 강의 본문과 연자 Q&A를 구분해 수록했다.

참고한 자료

아산 28회 연수강좌 — 월경이 불규칙한 환자, 무엇을 확인해야 하나?(이사라)

SCAN TO REVISIT

자료 다시 보기

QR로 같은 강의 학습 자료를
다시 열 수 있습니다

의료진 학습용 · 아산 28회 연수강좌의 전사·교재·질의응답을 바탕으로 구성했다.